한국투자증권

대체투자

2026. 9. 14

대체투자 Note

헬스케어 사모대출의 변화

이혜원
hwlee@koreainvestment.com

결론: 헬스케어 대출의 중심이 M&A 기반 의료서비스 플랫폼에서 세부업종별 투자로 이동

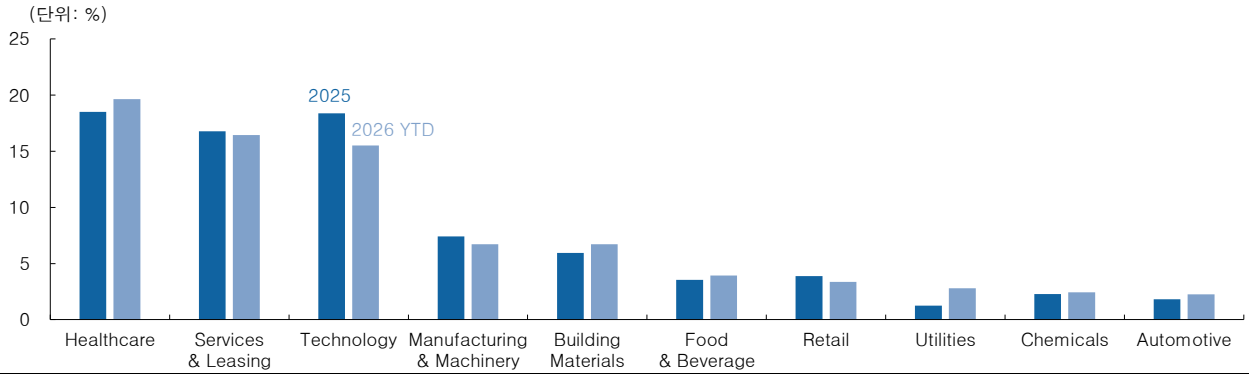
2026년 헬스케어는 신규 직접대출의 주류 업종으로 자리잡았지만, 그 내부 구성은 과거와 달라지고 있다. 과거에는 의료서비스 제공자의 buy-and-build와 플랫폼화가 반복 가능한 투자공식으로 활용됐으나, 2022년 이후 금리·인건비·수가·엑싯 환경이 바뀌면서 그 공식의 유효성이 약해졌다. 이후 사모대출은 헬스케어 IT, 생명과학 서비스, 의료기기, 제약·바이오 등 서로 다른 성장동인과 위험을 가진 세부업종으로 투자대상을 넓히고 있으며, 이에 따라 운용사의 세부업종별 언더라이팅 역량이 다시 중요해지고 있다.

소프트웨어와 달리 헬스케어에는 신규 자금 유입 지속

2026년 사모대출 시장에서는 업종별 자금배분 차이가 뚜렷하다. 소프트웨어는 AI가 기존 제품의 성장성과 가격결정력을 훼손할 수 있다는 우려로 신규 투자가 둔화됐다. 반면 Healthcare는 2025년 Technology를 근소하게 앞선 데 이어 2026년 비중이 추가 확대되며 뚜렷한 1위로 올라섰다. 소프트웨어에 대한 자금공급은 빠르게 보수화된 반면, 헬스케어에는 신규 자금이 계속 유입되고 있다.

그렇다고 헬스케어의 신용위험이 낮았던 것도 아니다. 최근 사모대출 시장의 관심은 이른바 'SaaSpocalypse' 이후 소프트웨어에 집중돼 있지만, 헬스케어는 그보다 앞서 문제가 현실화된 대표 업종 중 하나였다. 특히 의료서비스 제공자는 코로나19 이전부터 PE roll-up 과정에서 높아진 레버리지와 반복적인 인수에 대한 우려가 있었고, 팬데믹 이후에는 의료인력 부족에 따른 인건비 상승, 보험수가 인상 지연, 변동금리 부담과 통합비용까지 겹치면서 신용부담이 본격적으로 확대됐다. AI가 소프트웨어에 미칠 영향은 아직 크기와 시점이 불확실한 반면, 헬스케어에서는 이미 신용문제가 PIK 전환, 만기연장, 부채감축과 대주 주도 구조조정 등으로 확인되고 있는 것이다. 그럼에도 헬스케어 신규대출이 줄지 않는다면, 헬스케어 안에서 실제 대출대상이 어떻게 달라지고 있는지를 살펴볼 필요가 있다.

[그림 1] 2025년 및 2026년 YTD 직접대출 업종별 투자비중



주: 2026년은 연초 이후 누적 기준
자료: PitchBook, 한국투자증권

한국투자증권은 당사 고객 및 별도의 서비스 계약을 맺은 법인에게만 리서치 리포트를 공개하고 있습니다. 한국투자증권의 사전 승인 없이 리포트를 어떤 형태로든 복제, 배포, 전송, 변형 및 판매하는 행위는 저작권법 위반으로 법적 처벌의 대상이 될 수 있음을 알려드립니다.

헬스케어 섹터 내 의료서비스 제공자 중심 구조가 약화

분석대상 BDC의 광의 헬스케어 익스포저는 전체 포트폴리오의 18.6%

이에 2026년 2분기 22개 BDC의 보유내역을 차주 단위로 재분류했다. 실제 사업내용을 기준으로 의료서비스 제공자, 헬스케어 IT, 생명과학 서비스, 의료서비스 연관, 의료기기, 제약·바이오의 6개 세부업종으로 구분했다. 분석대상 광의 헬스케어 익스포저는 약 640억달러로 전체 포트폴리오의 약 18.6%이며, 운용사와 차주의 최초 거래시점을 ≤2022, 2023~2024, 2025~2026으로 나눠 구성을 비교했다.

표 1. 헬스케어 세부업종 분류 및 주요 사업

하위 업종 구분	사업내용	대표 사업
의료서비스 제공자	환자에게 직접 진료·치료를 제공하는 병·의원 및 진료 플랫폼	치과, 수의, 안과, 피부과, 행동건강, 여성건강, 외래진료
헬스케어 IT	의료기관·보험자의 업무, 청구, 임상정보 및 데이터를 관리하는 소프트웨어·정보서비스	EHR(Electronic Health Record; 전자의무기록), RCM(Revenue Cycle Management; 진료비 청구·수납 및 매출관리) 소프트웨어·플랫폼, 진료·예약·처방 등 임상업무 관리 시스템, 의료데이터 플랫폼
생명과학 서비스	제약·바이오 회사의 연구·개발·시험·생산을 외부에서 지원	CRO(Contract Research Organization; 임상시험과 연구개발 지원), CDMO(Contract Development and Manufacturing Organization; 의약품 개발 및 생산 위탁), 바이오 분석, 임상시험 지원
의료서비스 연관	직접 진료는 하지 않지만 의료서비스 운영과 보험청구, 의료비용 관리 등 운영 인프라 제공	전문약국, 보험청구 관리, 비용관리, 의료 유통
의료기기	진단·수술·치료에 사용되는 장비와 의료용 소모품	진단장비, 치료장비, 수술기기, 의료용 소모품
제약·바이오	상업화된 의약품과 바이오제품, 파이프라인을 직접 개발·판매	상업화 의약품, 신약·바이오 파이프라인

자료: 한국투자증권

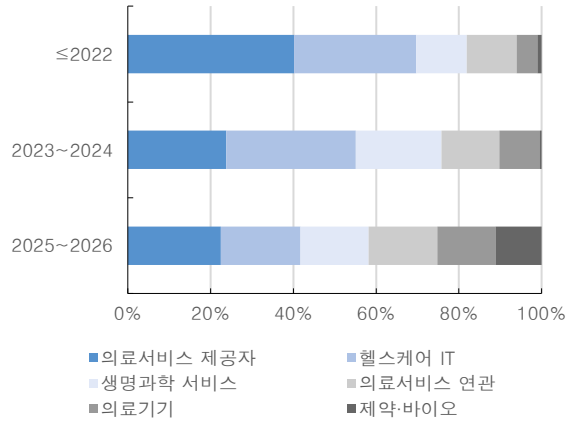
22년 이후 의료서비스 제공자 비중은 감소 추세, 다른 업종은 증가

현재 보유자산에서 의료서비스 제공자 비중은 ≤2022 구간에서 가장 높았으나 2023~2024년 약 24%, 2025~2026년 약 22%로 낮아진다. 다만 현재 포트폴리오에는 이미 상환·매각된 대출이 제외돼 있어 오래된 정상대출은 상당 부분 회수됐을 가능성이 높고, 일부 의료서비스 자산은 엑싯 지연과 차환·만기연장으로 장기간 남아 있다. 따라서 ≤2022 구간의 높은 비중에는 당시 신규대출이 많았던 효과와 회수가 늦어진 자산의 잔존효과가 함께 반영돼 있다. 이후 헬스케어 IT·생명과학 서비스가 먼저 확대됐고, 2025~2026년에는 의료기기·제약·바이오·의료서비스 연관의 비중이 커졌다.

오래된 거래의 구조적 과소표시 제거 이후에도 의료서비스 제공자 투자 감소 확인

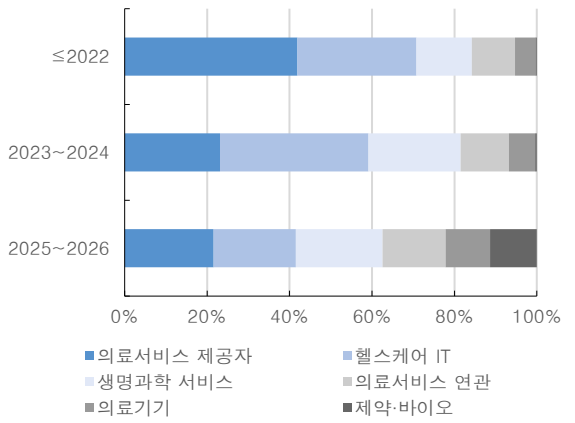
후발 BDC 편입에 따른 최근 거래의 과대표시 가능성도 별도로 점검했다. 현재 22개 BDC 중에는 2022년 이후 출범한 대형 비상장 BDC가 포함돼 있어 전체 표본만 사용하면 오래된 거래가 구조적으로 과소표시될 수 있다. 이에 2021년 말까지 운용을 시작한 BDC만 남겨 동일표본을 구성했다. 이 경우에도 의료서비스 제공자 비중은 ≤2022의 41.9%에서 2023~2024년 23.1%, 2025~2026년 21.6%로 낮아졌다. 현재 보유자산만을 분석한다는 한계는 있지만, 동일표본에서도 전체 표본과 같은 방향의 변화가 확인된다.

그림 2. 의료 서비스, 헬스케어 IT 비중 감소



주: 2026년 2분기 기준, 전체 22개 BDC 기준
자료: PitchBook, 한국투자증권

그림 3. 빈티지 효과를 고려해도 변화 방향 유지



주: 2026년 2분기 기준. 2021년 말까지 운용개시 BDC 동일표본 기준
자료: PitchBook, 한국투자증권

Buy-and-build, 플랫폼 전략은 의료서비스를 범용 LBO 자산화

Buy-and-build 확대로 의료서비스 투자의 표준화 진행

헬스케어는 원래 세부 사업에 대한 전문지식이 중요한 투자영역이었다. 특히 전문진료·의원 영역의 의료서비스 제공자는 진료과별로 수가체계와 인력구조, 환자유입, 규제가 달라 개별 사업에 대한 이해 없이 현금흐름을 평가하기 어려웠다. 그러나 치과·수의·안과·피부과·중독치료 등에서 buy-and-build가 확대되면서 이러한 복잡성이 일정 부분 반복 가능한 투자공식으로 바뀌었다. 이들 업종은 지역별로 소규모 병·의원이 분산돼 있어 하나의 플랫폼을 구축한 뒤 소규모 사업자를 반복적으로 인수하기에 적합했다.

반복 인수와 중앙운영으로 플랫폼 가치 확대

소형 병·의원을 플랫폼보다 낮은 배수에 인수하고, 인수 후 청구·회계·인사·구매·IT 등 관리 기능을 중앙화해 비용을 줄일 수 있었다. 또한 의료수가는 보험자와의 계약이나 공적 수가체계에 따라 비교적 예측 가능했고, 팬데믹 이전에는 의료인력 비용 상승도 상대적으로 안정적이어서 인수 후 마진을 관리하기 용이했다. 여기에 플랫폼 규모가 커질수록 매각 시 더 높은 밸류에이션 배수를 적용받을 가능성도 높아졌다. 이처럼 하나의 플랫폼을 중심으로 소규모 병·의원을 반복적으로 인수해 규모를 키우는 방식이 의료서비스 제공자 roll-up의 전형적인 구조였다. 낮은 배수의 add-on 인수 → 비용절감 → EBITDA 확대 → 플랫폼 가치 상승 → 추가 인수 여력 확대라는 선순환이 가능했던 것이다. 이처럼 buy-and-build와 플랫폼화가 반복 가능한 투자공식으로 자리잡으면서, 의료서비스는 전문 투자자뿐 아니라 범용 PE도 대규모로 접근할 수 있는 LBO 자산으로 확대됐다.

대주도 M&A·레버리지 중심으로 반복 언더라이팅 가능

대주 입장에서도 언더라이팅을 반복하기 쉬웠다. 최초 플랫폼 인수금융 이후 DDTL이나 추가 한도대출을 제공해 후속 인수를 지원하고, 개별 진료과의 차이보다는 스폰서의 인수 파이프라인과 통합능력, 인수 후 예상 EBITDA와 레버리지 등을 중심으로 대출구조를 만들 수 있었다. 세부 진료영역에 대한 전문성은 여전히 필요했지만, M&A 실행과 중앙운영, 자본구조 관리가 투자성과를 좌우하는 주요 변수로 부상하면서 범용 PE와 직접대출 운용사도 대규모로 접근할 수 있게 됐다.

금리·비용·엑싯 환경 악화로 의료서비스 플랫폼의 선순환이 약화

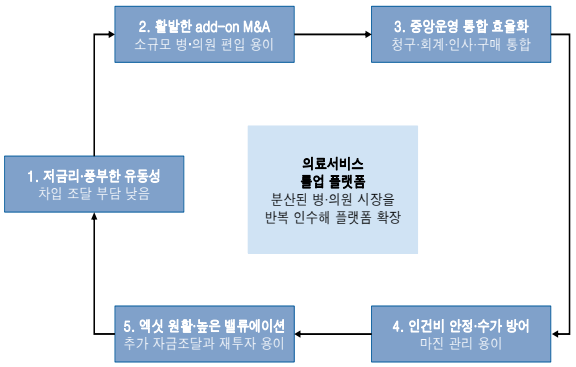
2022년 이후 금리·인건비·수가 부담으로 기존 공식 약화

문제는 이러한 M&A 기반 성장공식을 지탱했던 변수들이 2022년 이후 상당 부분 반대 방향으로 움직이기 시작했다는 점이다. 우선 금리상승으로 add-on 인수를 차입으로 계속 조달하는 비용이 급격히 높아졌다. 동시에 의료인력 부족으로 임금은 빠르게 올랐지만 보험수가는 비용 상승을 같은 속도로 반영하지 못했다. 즉 과거에는 인수 후 중앙운영을 통해 확보했던 마진개선 효과보다 인건비와 금융비용 상승이 더 크게 나타날 수 있는 환경으로 바뀌었다. 인수한 병·의원의 시스템과 인력, 조직문화를 통합하는 비용도 예상보다 크게 나타났다.

엑싯 위축까지 겹치며 기존 롤업의 선순환이 역전

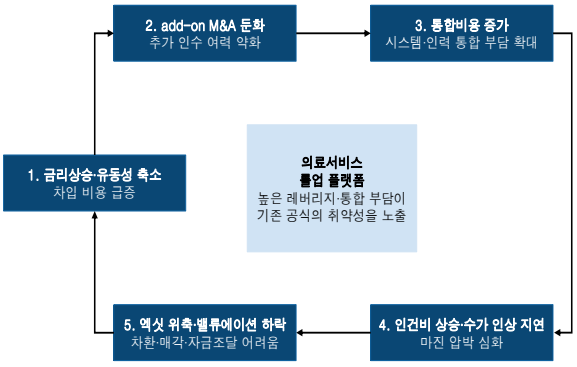
엑싯 환경까지 악화됐다. 높은 매입배수와 지속적인 add-on 인수로 규모가 커진 플랫폼을 과거보다 더 높은 배수에 다음 스폰서에게 매각해야 기존 투자공식이 완성되지만, 금리상승 이후 차입여력이 줄고 PE의 매수가격도 낮아졌다. 플랫폼 규모가 지나치게 커져 전략적 매수자 후보가 제한되는 문제도 나타났다. 과거에는 낮은 금리와 활발한 M&A 시장이 '추가 인수 → EBITDA 확대 → 높은 배수의 엑싯'이라는 선순환을 만들었다면, 지금은 높은 차입비용 → add-on 둔화 → 비용상승과 통합부담 → EBITDA 개선 지연 → 엑싯 지연이라는 반대의 고리가 작동하고 있다.

그림 4. 과거(~2021): 롤업의 선순환 구조



주: 2026년 2분기 기준, 전체 22개 BDC 기준
자료: PitchBook, 한국투자증권

그림 5. 현재(~2022~): 롤업의 악순환 구조



주: 2026년 2분기 기준. 2021년 말까지 운용개시 BDC 동일표본 기준
자료: PitchBook, 한국투자증권

헬스케어 대출은 서로 다른 성장동인을 가진 세부업종으로 이동

대출대상이 서로 다른 성장동인을 가진 세부업종으로 확대

M&A와 플랫폼화를 기반으로 한 의료서비스의 투자공식이 약해졌지만, 오히려 사모대출은 M&A 기반 의료서비스 플랫폼 중심의 구조에서 벗어나 서로 다른 성장동인과 위험을 가진 세부업종으로 투자대상을 넓히고 있다. 즉 같은 Healthcare 안에서도 최근에는 감수하는 위험의 종류가 달라지고 있으며, 이에 따라 대출대상과 언더라이팅 방식도 함께 바뀌고 있다. 과거처럼 M&A와 플랫폼화를 기반으로 한 공통 공식을 반복 적용하기보다 각 업종의 사업모델과 현금흐름 동인을 개별적으로 언더라이팅하는 구조로 전환되고 있는 것이다.

표 2. 최근 확대되는 헬스케어 세부업종별 성장동인과 주요 위험

세부업종	성장동인	주요위험
헬스케어 IT	의료기관·보험자의 인력부족과 비용압박에 따른 업무 자동화 및 데이터 활용 수요 확대	AI가 기존 기능과 가격결정력에 미치는 영향, 제품별 경쟁우위, 높은 레버리지
생명과학 서비스	제약·바이오 기업의 R&D·생산 과정 복잡화와 연구개발·임상·생산 기능의 외주화 확대	고객집중, 바이오기업 자금조달 환경, 임상실패, 설비가동률, 품질·규제
의료서비스 연관	보험청구·비용관리·전문약국·유통 등 의료서비스 운영기능의 외주화 및 전문화	보험자·고객집중, 노동집약도, 자동화·AI 대체 가능성
의료기기	시술량 증가, 설치기반 확대, 제품 교체수요와 신제품의 임상채택	제품주기, 규제승인, 제조·품질관리, 병원 설비투자, 수가
제약·바이오	신약 출시와 적응증 확대, 제품 성장 및 파이프라인 개발	특정 제품 의존, 특허만료, 약가, 임상 파이프라인 위험

자료: 한국투자증권

표준화된 언더라이팅이 약해지며 세부업종 전문성이 다시 중요

소프트웨어와 헬스케어 모두 표준화된 언더라이팅 공식 약화

이 변화는 소프트웨어가 걸어온 경로와 유사하다. 소프트웨어도 원래 제품과 기술에 대한 전문성이 중요한 투자영역이었지만, SaaS와 ARR, 높은 고객 유지율이 보편화되면서 반복 매출을 비교적 표준화된 현금흐름으로 평가할 수 있게 됐다. 그 결과 범용 PE와 직접대출 운용사까지 대규모로 접근할 수 있는 LBO 자산으로 확대됐다. 그러나 AI가 같은 SaaS 안에서도 제품의 방어력, 업무흐름 내 위치, 독점적 데이터와 고객전환비용을 다시 구분하게 만들면서 기존의 표준화된 언더라이팅 공식이 흔들리고 있다. 헬스케어에서는 의료서비스 제공자의 buy-and-build와 플랫폼화가 이와 비슷한 역할을 했다. 세부 진료영역의 수가와 규제를 모두 깊이 이해하지 않더라도 add-on M&A, 중앙운영, 레버리지 관리라는 공통 틀로 상당수 플랫폼을 평가할 수 있었지만, 지금은 이 공식 역시 약화되고 있다. 동시에 자금이 생명과학 서비스, 의료기기, 제약·바이오 등으로 넓어지면서 고객, 규제, 기술, 제품, 파이프라인 등 세부 사업별 요소를 직접 평가해야 할 필요는 오히려 커졌다.

세부업종별 전문성이 운용사 성과를 가르는 요인으로 부상

McKinsey도 2026년 Healthcare PE에서 금융공학보다 운영 실행과 깊은 운영역량, 세부 전문성의 중요성을 강조했다. 이는 헬스케어 투자가 다시 예전의 좁은 전문성의 영역으로 돌아간다는 뜻은 아니지만, 적어도 과거처럼 업종명과 공통 재무지표만으로 반복 가능한 공식을 적용하기는 어려워졌다는 것을 의미한다. 어느 운용사가 어떤 세부업종을 늘리고 있는지, 해당 팀이 그 산업의 규제·고객·기술·운영구조를 실제로 이해하고 있는지, 그리고 이러한 전문성이 과거 신용성과와 신규 언더라이팅에 어떻게 반영되고 있는지가 중요하다. 결국 표준화된 투자공식의 유효성이 약해질수록 운용사의 세부업종별 언더라이팅 역량이 성과를 가르는 요인으로 다시 중요해질 가능성이 높다.

.

■ 본 리포트는 고객의 증권투자를 돕기 위하여 작성된 당사의 저작물로서 모든 저작권은 당사에게 있으며, 당사의 동의 없이 어떤 형태로든 복제, 배포, 전송, 변형할 수 없습니다.

■ 본 리포트는 당사 리서치본부에서 수집한 자료 및 정보를 기초로 작성된 것이나 당사가 그 자료 및 정보의 정확성이나 완전성을 보장할 수는 없으므로 당사는 본 리포트로써 고객의 투자 결과에 대한 어떠한 보장도 행하는 것이 아닙니다. 최종적 투자 결정은 고객의 판단에 기초한 것이며 본 리포트는 투자 결과와 관련한 법적 분쟁에서 증거로 사용될 수 없습니다.

■ 본 리포트에 제시된 종목들은 리서치본부에서 수집한 자료 및 정보 또는 계량화된 모델을 기초로 작성된 것이나, 당사의 공식적인 의견과는 다를 수 있습니다.

■ 이 리포트에 게재된 내용들은 작성자의 의견을 정확하게 반영하고 있으며, 외부의 부당한 압력이나 간섭없이 작성되었음을 확인합니다.